Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Аденоидэктомия

Удаление аденоидов

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Дополнительные процедуры в ту же сессию: ☐ Тонзиллэктомия ☐ Вентиляционная(-ые) трубка(-и) ☐ Нет

_____

Показание к операции (заполняет врач):
☐ Заложенность носа / храп / апноэ сна
☐ Экссудативный средний отит / частые воспаления уха
☐ Рецидивирующий аденоидит / синусит _____

Другое / примечания: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Аденоиды — это лимфоидная ткань, часть иммунной системы организма, расположенная в задней части носа, над нёбом. Они могут увеличиваться, особенно у детей в возрасте 2–7 лет, и обычно уменьшаются начиная с подросткового возраста.

Увеличенные аденоиды могут перекрывать заднюю часть носа и вызывать **дыхание через рот, храп, остановки дыхания во сне, насморк, гнусавость голоса и частые инфекции**. Поскольку они также могут перекрывать устье слуховой (евстахиевой) трубы, соединяющей ухо с задней частью носа, они могут приводить к **скоплению жидкости в среднем ухе (экссудативному среднему отиту), снижению слуха и повторяющимся воспалениям уха**. Длительное дыхание через рот может также влиять на развитие лица и зубов.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Цель аденоидэктомии — удалить увеличенную аденоидную ткань, чтобы облегчить носовое дыхание и уменьшить проблемы с ушами, пазухами и дыхательными путями. Врач отдельно объяснит, почему эта операция рекомендована вам или вашему ребёнку.

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится под общей анестезией в операционной. Она выполняется через рот; **снаружи нет никаких разрезов или рубцов.**

1. **Подготовка:** После введения анестезии устанавливают специальный инструмент, удерживающий рот открытым, и осторожно приподнимают мягкое нёбо, чтобы была видна задняя часть носа.
2. **Удаление аденоидов:** Аденоиды удаляют из задней части носа с помощью кюретки (специального инструмента для соскабливания), микродебридера под контролем эндоскопа, коблации или диатермии. Поскольку аденоиды — это ткань, а не отдельный орган, их невозможно удалить «с корнем»; цель — безопасно удалить ту часть, которая вызывает заложенность.
3. **Остановка кровотечения:** На короткое время к области прикладывают тампон для прижатия и при необходимости останавливают кровотечение диатермией. В конце операции в задней части носа тампоны не оставляют.
4. **Дополнительные процедуры:** Если это запланировано, под той же анестезией выполняют удаление нёбных миндалин (тонзиллэктомию) или установку вентиляционных трубок в барабанные перепонки. Для этих процедур заполняются отдельные формы согласия.
5. **Пробуждение:** После операции пациент находится под пристальным наблюдением в палате пробуждения до полного пробуждения.

Если врач сочтёт это необходимым, удалённую ткань направляют на патоморфологическое (гистологическое) исследование.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общая анестезия	Около 20–30 минут (без учёта времени анестезии)	Обычно выписка домой в тот же день; при необходимости наблюдение в течение одной ночи

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более свободное носовое дыхание, меньше храпа и остановок дыхания во сне
- Более качественный сон и, как следствие, улучшение внимания, поведения и успеваемости в течение дня
- Меньше эпизодов скопления жидкости в среднем ухе и воспалений уха, что способствует улучшению слуха
- Меньше выделений из носа, реже синуситы и инфекции верхних дыхательных путей

У тщательно отобранных пациентов заложенность носа и храп в подавляющем большинстве случаев заметно уменьшаются. Однако если у заложенности есть и другие причины — например, аллергия, увеличенные носовые раковины или искривление перегородки, — симптомы могут пройти не полностью. Успех лечения проблем с ушами зависит также от развития слуховой трубы; некоторым детям может потребоваться дополнительное лечение или вентиляционные трубки.

4 Другие варианты лечения

- **Наблюдение:** Если симптомы выражены слабо, можно подождать, регулярно проходя осмотры, поскольку с возрастом аденоиды уменьшаются.
- **Лекарства:** Назальные спреи с кортикостероидами у некоторых детей могут временно уменьшить отёк аденоидов и заложенность; при наличии аллергии проводится её лечение. Эффект обычно сохраняется лишь до тех пор, пока применяется лекарство.
- **Только вентиляционные трубки при проблемах с ушами:** В некоторых случаях может рассматриваться установка трубок в барабанные перепонки без удаления аденоидов.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Другие варианты при апноэ сна:** В очень редких случаях, когда операция не подходит, во время сна может использоваться аппарат для создания постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP).

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, аденоиды могут уменьшиться сами по себе в подростковом возрасте. Однако до этого времени могут сохраняться дыхание через рот, храп, плохой сон, повторяющиеся инфекции и снижение слуха из-за жидкости в ухе. Длительные и тяжёлые нарушения дыхания во сне у детей могут приводить к замедлению роста и развития, проблемам с вниманием и поведением, а в редких случаях — к нагрузке на сердце и лёгкие. Жидкость в среднем ухе, сохраняющаяся длительное время, может влиять на развитие речи и вызывать стойкие изменения барабанной перепонки.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводятся анализы крови (особенно на свёртываемость) и другие необходимые обследования; вас также осмотрит врач-анестезиолог.
- Пожалуйста, обязательно сообщите нам, если в семье были случаи повышенной кровоточивости, легко возникающих синяков или нарушений свёртываемости крови.
- В течение **6 часов** до операции нельзя давать твёрдую пищу и молоко; в отношении прозрачных жидкостей соблюдайте время, указанное анестезиологом.
- Пожалуйста, сообщите нам, если в течение 2–3 недель до операции была повышенная температура, диарея, кашель или грипп; операцию, возможно, придётся отложить.
- Если есть шатающийся молочный зуб, скажите об этом врачу, так как он может выпасть во время анестезии.
- Рекомендуем подготовить ребёнка к операции, используя понятные для его возраста слова, которые его не напугают.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин E, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

День операции	После пробуждения могут быть небольшая боль в горле, слизистые выделения из носа с примесью крови и дыхание через рот. Может возникнуть рвота или небольшое повышение температуры. Когда тошнота проходит, сначала дают воду, затем тёплую мягкую пищу. Большинство пациентов уходят домой в тот же день.
Первые 3–5 дней	Из-за отёка могут ещё сохраняться заложенность носа и храп; возможны неприятный запах изо рта, небольшое повышение температуры, боль в ухе и боль в шее. Боль

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	обычно слабая и снимается обезболивающими, рекомендованными врачом. Важно пить много жидкости.
1-я неделя	Большинство детей могут вернуться в школу или детский сад в течение 3–7 дней, а взрослые — на работу. В первую неделю избегайте людных мест и контактов с людьми, у которых есть инфекция.
2–4-я недели	По мере спадания отёка носовое дыхание заметно улучшается. Временная гнусавость голоса, если она была, обычно проходит в этот период. Плавание и интенсивные физические нагрузки, как правило, разрешаются через 2 недели.
1–3-й месяцы	Проводится контрольный осмотр; если операция была выполнена из-за проблем с ушами, состояние ушей проверяют с помощью исследования слуха и тимпанометрии.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Небольшая боль в горле и дискомфорт при глотании
- Слизистые выделения из носа с примесью крови и заложенность носа в течение нескольких дней
- Неприятный запах изо рта (из-за заживающей раневой поверхности; проходит в течение 1–2 недель)
- Боль в ухе (отражённая боль по общим нервам; она не означает, что в ухе есть проблема)
- Небольшое повышение температуры (в первые 1–2 дня), тошнота и рвота из-за анестезии

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Временная гнусавость голоса** — После удаления аденоидов нёбу требуется время, чтобы приспособиться; в течение от нескольких дней до нескольких недель при разговоре воздух может выходить через нос, а иногда жидкость может попадать обратно в нос. Обычно это проходит само по себе в течение 1–2 месяцев.
- **Боль и скованность в шее** — Из-за положения во время операции и заживления в задней части носа в первые дни движения шеей могут быть болезненными; обычно это проходит в течение нескольких дней.
- **Симптомы проходят не полностью** — Если есть дополнительные причины, такие как аллергия, увеличенные носовые раковины или искривление перегородки, заложенность носа может частично сохраняться; может потребоваться дополнительное лечение.

Нечастые состояния

- **Кровотечение** — Значительное кровотечение после операции возникает **менее чем у 1 из 100 пациентов (примерно у 0,5–1 из 100)**. Чаще всего оно возникает в первые 24 часа. Если кровотечение не удаётся остановить, может потребоваться **повторное вмешательство в операционной под общей анестезией для его остановки**. Переливание крови требуется очень редко.
- **Повреждение зубов** — Давление инструмента, удерживающего рот открытым, может привести к отколу или выпадению зуба, особенно если он уже шатается или поражён кариесом.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Травма или отёк губ, языка или нёба** — Из-за контакта с инструментами могут возникнуть небольшие ранки или временный отёк; они заживают в течение нескольких дней.
- **Инфекция** — Может проявляться повышением температуры, усилением неприятного запаха изо рта и нарастанием боли; обычно проходит при лечении антибиотиками.
- **Повторное разрастание аденоидов** — Аденоидная ткань может вырасти снова (примерно у **1–5 из 100** пациентов), особенно у прооперированных в очень раннем возрасте и у страдающих аллергией. Если симптомы возвращаются, в редких случаях может потребоваться повторная операция.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Стойкая гнусавость / попадание жидкости обратно в нос (велофарингеальная недостаточность)** — Встречается примерно у **1 из 1500–3000** пациентов; риск выше у детей со скрытой расщелиной нёба (подслизистой расщелиной). Обычно состояние улучшается при занятиях с логопедом; в редких случаях может потребоваться корригирующая операция. Именно поэтому перед операцией нёбо тщательно осматривают.
- **Смещение шейных позвонков (синдром Гризеля)** — **Очень редкое** состояние, при котором воспаление в задней части носа затрагивает связки верхних шейных позвонков. Проявляется болью в шее, которая начинается в дни после операции и постепенно усиливается, невозможностью повернуть голову и наклонённым набок положением головы. При раннем выявлении его лечат лекарствами и шейным воротником; при поздней диагностике может потребоваться более длительное лечение или, в редких случаях, операция, и может остаться стойкое ограничение подвижности шеи. Поэтому о постепенно усиливающейся боли в шее необходимо обязательно сообщать.
- **Рубцевание или сужение в задней части носа** — Очень редко, особенно при удалении большого объёма ткани одновременно с тонзиллэктомией, во время заживления в задней части носа может развиться сужение; это может вызвать заложенность носа и потребовать дополнительного лечения.
- **Тяжёлое кровотечение и его последствия** — Крайне редко при наличии аномально расположенного кровеносного сосуда или невыявленного нарушения свёртываемости крови может возникнуть тяжёлое кровотечение. В этом случае может потребоваться экстренная операция, переливание крови и лечение в **отделении интенсивной терапии**; попадание крови в дыхательные пути может вызвать проблемы с дыханием.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Свежая, ярко-красная кровь** изо рта или носа, сплёвывание крови или рвота кровью (о любом кровотечении, кроме нескольких капель, нужно сообщить)
- Частое глотание (у детей — важный признак того, что кровь заглатывается), бледность, слабость
- **Температура выше 38,5 °C** или температура, которая не снижается после приёма обезболивающих
- Полный отказ от питья, отсутствие мочеиспускания в течение 6–8 часов, необычная сонливость (признаки обезвоживания)
- Постепенно усиливающаяся **боль в шее**, невозможность повернуть голову или наклонённое набок положение головы
- Затруднённое дыхание или выраженные остановки дыхания во сне

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Для обезболивания используйте только **обезболивающие, рекомендованные врачом**; аспирин и препараты, содержащие аспирин, применять нельзя, так как они могут усиливать кровотечение.
- В первые дни рекомендуется тёплая или прохладная мягкая пища и **обильное питьё**; избегайте очень горячей, твёрдой и острой пищи.
- В течение первой недели не сморкайтесь с силой.
- Если в первую неделю после операции запланирован обратный перелёт за рубеж, обсудите с врачом, когда самое раннее можно безопасно лететь; из-за риска кровотечения в первые дни рекомендуется оставаться там, откуда можно быстро связаться с врачом и добраться до него.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Мне разъяснили, что в первые дни после операции, особенно в случае моего ребёнка, я должен(-на) следить за признаками кровотечения (частое глотание, сплёвывание крови или рвота кровью) и связаться с врачом.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.